ANEXO 8
TASA DE ESAVI SEVEROS ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN Y TIEMPO DE APARICIÓN

VACUNA	EVENTO	TIEMPO QUE TARDA EN APARECER	TASAS POR 1000000 DE DOSIS
BCG a,b	Linfadenitis supurativa	2 a 6 meses	100 a 1000
	Osteítis por BCG ("becegeítis")	1 a 12 meses	1 a 700
	"Becegeítis" diseminada por la BCG	1 a 12 meses	0.19 a 1.56
HIB [a]	Ninguna conocida	-	-
Hepatitis B [a]	Anafilaxia	0 a 1 hora	1 a 2
Antisarampionosa /	Convulsiones febriles	7 a 12 días	17 a 50
SPR-SR [a,c]	Trombocitopenia (recuento bajo de plaquetas)	15 a 35 días	25 a 33
	Anafilaxia	0 a 1 hora	10
	Parotiditis	-	raro
	Sordera [d]	< 2 meses	raro
	Encefalopatía [d]	< 2 meses	<1
	Meningitis aséptica [e]	18 a 34 días	0.1
Antipoliomielítica oral	Poliomielitis paralítica relacionada con la vacuna (PPRV)	4 a 40 días	0.004 a 0.1 [f]
(VOP) [a]	Anafilaxia	0 a 1 hora	rara
TT/DT [a]	Neuritis del plexo braquial	2 a 28 días	5 a 10
	Anafilaxia	0 a 1 hora	1 a 6
	Absceso estéril	1 a 6 semanas	1 a 10
DTP [a]	Llanto persistente que dura más de 3 horas	0 a 24 horas	1 000 a 60 000
	Convulsiones [g]	0 a 2 días	570
	Episodio de hipotonía e hipo reactividad	0 a 24 horas	570
	Anafilaxia	0 a 1 hora	20
	Encefalopatía [h]	0 a 3 días	0 a 1
Fiebre amarilla [a]	Enfermedad neurotrópica	3 a 28 días	500 a 4 000 en < de 6m [i]
	Reacción alérgica / anafilaxia	0 a 1 hora	4 a 18
	Enfermedad viscerotrópica	1 a 8 días	4 [j]
Rabia (CRL)	Reacción neurológica [k]	4 a 25 días	300 a 800
VPH (Gardasil)	Anafilaxia	0 a 1 hora	Rara
Influenza estacional	Anafilaxia	0 a 1 hora	< 2
	Guillain-Barré [l]	6 semanas	1
	Síndrome óculo-respiratorio		90 a 466
Antineumocócica vacuna conjugada	Ninguna conocida	-	-
Influenza pandémica	Ninguna conocida [m]	-	-

Fuente: Adaptado de Turpo G, Ticona M, Whittembury A, diciembre 2009 - enero 2010.

Modificado de los módulos de capacitación de vacunación segura de la OPS (2007).

a) Estas reacciones se presentan principalmente en niños con compromiso de la inmunidad celular.

b) No hay reacciones adversas (excepto anafilaxia) cuando hay inmunidad (~90 % de los que reciben una segunda dosis). Las convulsiones febriles son poco probables en niños mayores de seis años. La trombocitopenia es transitoria y benigna; hay reportes que indican que podría ser mayor en personas con antecedente de púrpura trombocitopénica idiopática.

c) Hay relación temporal, pero no se ha podido establecer una relación causal.

d) Relacionado con el componente de parotiditis; no obstante, hay mucha diversidad en la información, se requieren más estudios.

e) El riesgo de PPRV es 0.1 casos por millón de dosis para la primera dosis y 0.004 para las demás dosis. En promedio, el riesgo para todas las dosis es de 0.04 por millón de dosis.

f) Las convulsiones son febriles, principalmente, y la tasa depende de los antecedentes personales y familiares y la edad, con un riesgo más bajo en lactantes menores de 4 meses. No dejan secuelas.

g) No ha sido confirmada por los estudios realizados.

h) El riesgo es mayor en menores de 6 meses, pero se han presentado casos en otros grupos de edad. La tasa promedio es de 8 por millón de dosis, en personas de 60 a 69 es de 16 por millón de dosis y en mayores de 70 es de 23 casos por millón de dosis administradas.

i) El riesgo se incrementa con la edad. En personas de 60 a 69 años de edad la tasa es de 10 por millón de dosis y en mayores de 70 años es de 23 por millón de dosis administradas. En el Perú se identificó un conglomerado con una tasa de 79 por millón de dosis.

j) Las reacciones neurológicas reportadas para la vacuna de cerebro lactante de ratón afectan mayormente el sistema nervioso periférico y se suelen manifestar como parálisis flácidas agudas, especialmente Síndrome de Guillaín-Barré. La OMS ha recomendado la descontinuación de su uso y el cambio por vacunas de cultivos celulares.

k) Sólo para la vacuna de 1976. Actualmente no se ha encontrado relación causal entre la vacuna de influenza estacional y el Síndrome de Guillain-Barré.

l) Hasta el momento no se ha podido identificar eventos adversos serios relacionados a la vacuna pandémica; no obstante, es de esperarse que sean semejantes a la vacuna estacional.





ANEXO 9
ERRORES OPERATIVOS DEL PROGRAMA Y SU CONSECUENCIA

ERROR OPERATIVO	EVENTO PREVISTO
Inyección no estéril:	
• Reutilización de jeringa o aguja descartable. • Uso de jeringas sin garantía de esterilidad adecuada. • Vacuna o diluyente contaminado. • Uso de vacunas liofilizadas por más del tiempo indicado de uso.	• Infección: absceso localizado en el sitio de inyección, sepsis, síndrome de choque tóxico o muerte. Infección transmitida por la sangre, como hepatitis o VIH.
Error de reconstitución:	
• Reconstitución con diluyente incorrecto. • Reemplazo de la vacuna o diluyente con un fármaco.	• Absceso local por agitación indebida. • Efecto adverso de un fármaco; ejemplo, insulina. • Muerte. • Vacuna ineficaz.
Inyección en el lugar equivocado:	
• BCG aplicada por vía subcutánea. • DTP / DT / TT demasiado superficial. • Inyección en glúteo.	• Reacción o absceso local. • Reacción o absceso local. • Daño al nervio ciático.
Transporte / almacenamiento incorrecto de vacunas.	• Reacción local por vacuna congelada. • Vacuna ineficaz.
Caso omiso de las contraindicaciones.	• Reacción grave previsible.

Fuente: con modificaciones de "Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura: módulos de capacitación. Módulo VI Sistema de monitoreo de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Washington, D.C.: OPS, 2007."

Whittembury A, et al. Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunación o Inmunización. Rev. Perú. Epidemiol. Vol. 13 N° 3 diciembre 2009.





ANEXO 10

PERÚ | Ministerio de Salud

REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN UNIFICADO

CÓDIGO RENIPRES: _____
DNI DEL VACUNADOR: _____
DNI DEL SUPERVISOR: _____
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD: _____
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN: _____
NOMBRE DEL SUPERVISOR: _____
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: Establecimiento ( ), Instituciones Educativas ( ), Casa por casa ( ), Visita Domiciliaria ( ), Puestos Fijos( ), Puestos Móviles ( )
CÓDIGO Y NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____
GRADO Y SECCIÓN: _____

ITEM	DATOS DEL VACUNADO										VACUNACIÓN							
	Nº DNI / HISTORIA CLINICA	APELLIDOS / NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO (Día/Mes/Año) / EDAD	TIPO EDAD	SEXO / PERTENENCIA ETNICA	DIRECCION	TELEFONO	RESIDENCIA HABITUAL: DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	FECHA DE APLICACIÓN: DÍA	MES	AÑO	VACUNA (Código CPMS)	LOTE (VACUNA)	DOSIS	GRUPO DE RIESGO	CO-MORBILIDAD (Colocar "X" de corresponder)	CONTACTO TBP (Colocar "X" de corresponder)
01																			
02																			
03																			
04																			
05																			
06																			
07																			
08																			
09																			
10																			

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

ANEXO 11

REGISTRO DIARIO DE VACUNACION DURANTE BLOQUEO VACUNAL

DIRIS/DIRESA/GERESA/ : _____ EE.SS _____

FECHA:

BLOQUEO VACUNAL																											
				CASA POR CASA									INFORMACIÓN RECOLECTADA				ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN										
N°	LOCALIDADES/SECTOR/	FECHA	N° DE BRIGADAS POR JORNADA	CASAS ABIERTAS			CASAS CERRADAS	CASAS ABANDONADAS	CASAS RENUENTE	TOTAL DE CASAS VISITADAS	TOTAL DE MANZANAS VISITADAS	NIÑOS ENCONTRADOS CON ESQUEMA COMPLETO	NIÑOS ENCONTRADOS CON ESQUEMA INCOMPLETO	NIÑO CON RECHAZO DE VACUNACIÓN / SIN INFORMACION VACUNAL	TOTAL DE NIÑOS ENCONTRADS DURANTE LA JORNADA	1 año		2 años		3 años		4 años		TOTAL DE NIÑOS VACUNADOS	Contactos directos del caso sospechoso (5-59 años)	RESPONSABLE DE LA JORNADA
				EFECTIVAS	NO EFECTIVAS	CASAS FALLIDAS										1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°		1 dosis	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

DJUNTAR FOTOS AQUI DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

mayor de edad (18 años) que brinda informacion.
Casas no efectivas (CNE): Viviendas en las que no se encuentre ninguna persona elegible que coincida con la poblacion objetivo a vacunar.
Casas fallidas (CFC): Viviendas en las que no se encuentre la población objetivo a vacunar, o no se encuentre persona mayor (18 años) que brinde información.
Casas cerradas (CC): Viviendas donde no se tiene respuesta por ausencia de la totalidad de sus habitantes
Casas abandonadas (CA): Viviendas en desuso sin mantenimiento ni evidencia de habitantes.
mayor de edad (18 anos), no desea brindar informacion o no

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Marleny Chanlos Aponte
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

ANEXO 12

CONSOLIDADO DE VACUNACION DURANTE BLOQUEO VACUNAL

GERESA/DIRESA/DIRIS

VACUNA:

JURISDICCIÓN	DISTRITO	EESS	FECHAS	BRIGADAS	TOTAL, DE POBLACION ENCONTRADA		ENCONTRADOS VACUNADOS ANTERIORMENTE			VACUNADOS DURANTE EL BLOQUEO			CASO SOSPECHOSO
					< 5años	> 5años	< 5años		> 5años	< 5años		> 5años	
							1ra dosis	2da dosis		1ra dosis	2da dosis		
Total					0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Marleny Chaclos Aponte
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

ANEXO 13
FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)[2]

CONFIDENCIAL

A. DATOS DEL PACIENTE

Nombres o iniciales:

Edad:	**Sexo** □ F □ M	**Peso (Kg):**	**Historia Clínica y DNI:**

Semanas de gestación (solo gestantes):

Establecimiento donde se vacunó:

B. EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

Describir el ESAVI

Fecha de inicio de ESAVI: _____./__./_ **Fecha final de ESAVI:** _____./__./____

Gravedad del ESAVI (Marcar con X)
□ Leve □ Moderado □ Grave

Solo para ESAVI grave (Marcar con X)
- □ Hospitalización
- □ Riesgo de muerte
- □ Discapacidad
- □ Anomalía congénita
- □ Fallecimiento Fecha (__/__/____)

Desenlace (Marcar con X)
□ En remisión □ Recuperado
□ Recuperado con secuela
□ No recuperado □ Mortal □ Desconocido
se realizó autopsia (mortal): □ Si □ No □ Desconocido

Resultados relevantes de exámenes de laboratorio (incluir fechas):

Otros datos importantes de la historia clínica, incluyendo condiciones médicas preexistentes, patologías concomitantes (ejemplo alergias, embarazo, consumo de alcohol, tabaco, disfunción renal/hepática, etc.)

C. VACUNA (S) SOSPECHOSA(S) | **DILUYENTE (si aplica)**

Nombre	**Laboratorio**	**Lote**	**Dosis 1,2,3**	**Vía de Adm/Sitio de Adm**	**Fecha vacunación**	**Hora de vacunación**	**Lote**	**Fecha Vencimiento**

El paciente recibió tratamiento para el evento □ Si □ No Especifique:

En caso de sospecha de problemas de calidad indicar:

[2] De acuerdo con lo establecido en el "Formato de Notificación de Eventos supuestamente atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI)" aprobado con la Resolución Directoral 001-2021-DIGEMID-DG-MINSA o la que haga sus veces.

Nº Registro Sanitario:_____./ Fecha de vencimiento_____./					
D. MEDICAMENTOS UTILIZADOS AL MOMENTO DE SER VACUNADO (excluir medicamentos para tratar el evento)					
Nombre comercial o genérico	**Dosis/ frecuencia**	**Vía de Adm.**	**Fecha inicio**	**Fecha final**	**Motivo de prescripción**
E. DATOS DEL NOTIFICADOR					
Establecimiento/ Institución:					
Nombres y apellidos:					
Teléfono:			**Correo electrónico:**		
Profesión:			**Fecha de notificación** ./ ./ .		**N° Notificación:**

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

1. Notifique, aunque Ud. no tenga la certeza de que la vacuna causó el ESAVI. La sospecha de una asociación es razón suficiente para notificar.
2. Notifique todos los eventos esperados o conocidos, inesperados o desconocidos, leves, moderados o graves relacionados con vacunas.
3. No deje de notificar por desconocer una parte de la información solicitada.
4. Si la información solicitada no está disponible, colocar "Desconocido".
5. Utilice un formato por paciente.
6. En caso de no contar con el espacio suficiente para el registro de la información, utilice hojas adicionales.
7. ESAVI grave: También conocido como SEVERO, es todo ESAVI que cumpla uno o más de los siguientes criterios: resulta en muerte, amenaza la vida, requiere hospitalización o prolonga la hospitalización, resulta en discapacidad significativa o permanente, en aborto o una anomalía congénita.
8. **Los ESAVIs graves se notifican dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el caso, y si son leves o moderados en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas y son enviados según el flujo de notificación establecido en cada establecimiento.**

A. DATOS DEL PACIENTE

Nombres o iniciales: Registrar los nombres o iniciales del paciente.
Edad: Use como referencia el primer signo, síntoma, hallazgo anormal de laboratorio, se expresa de forma numérica en años/ meses /días. En caso el dato no esté disponible se podrá colocar fecha de nacimiento (Día/Mes/Año)
Sexo: Marcar con una "X" la opción que corresponda
Peso: Expresarlo en Kg.
Historia Clínica y DNI: Completar la información solicitada.
Semanas de gestación: en el caso de que se trate de un gestante llenar el tiempo de gestación en semanas.
Establecimiento donde se vacunó: Indicar el nombre completo del establecimiento (hospital, centro de salud, puesto de salud u otra institución) donde recibió la(s) vacuna(s).

B. EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

ESAVI: Describa detalladamente cuáles fueron los signos o síntomas que considere puedan estar relacionados con la administración de la vacuna. Describa el evento resumiendo toda la información clínica relevante. Además, señalar el tiempo transcurrido

entre la vacunación y aparición de síntomas (días, horas, minutos). Indicar la modalidad de vacunación (programa regular, campaña, barrido o jornada).
Fecha de inicio de ESAVI: Indicar la fecha (Día/Mes/año) exacta en la cual se presentó el evento.
Fecha final de ESAVI: Indicar la fecha (Día/Mes/año) exacta en la cual desaparece el evento.
En caso de existir más de un ESAVI, describa la fecha de inicio y final de cada uno de ellos.
Gravedad del ESAVI: Marcar con "X" la gravedad del evento.
Si el ESAVI es grave marcar con una "X" la(s) opción(es) que apliquen.
Desenlace: Marcar con una "X" la opción que corresponda.
Si el desenlace fue mortal marcar con "X" si se realizó autopsia. Resultados relevantes de exámenes de laboratorio (incluir fechas): Resultados de pruebas de laboratorio usadas en el diagnóstico del evento.
Otros datos importantes de la historia clínica: Indicar condiciones médicas previas de importancia, así como patologías concomitantes (por ejemplo, Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, disfunción renal/hepática, etc.) u otras condiciones en el paciente (por ejemplo, alergias, embarazo, consumo de tabaco, alcohol, etc.).

C. **VACUNA (S) SOSPECHOSA(S) / DILUYENTE**
Nombre de la vacuna: Colocar el nombre indicado en el rotulado de la vacuna administrada, incluyendo la concentración y forma farmacéutica.
Laboratorio: Colocar el nombre del laboratorio fabricante.
Lote: Registrar las letras y/o números que indica el "lote" en el envase del producto.
Dosis: Indicar el número de dosis administrada.
Vía de administración: Señalar la vía de administración de la vacuna.
Sitio de administración: Indicar el lugar de administración de la vacuna (Ejemplo musculo deltoides derecho
Fecha de vacunación: señalar la fecha (Día/Mes/año) en que se realizó la vacunación
Hora de vacunación: Colocar la hora en recibió la vacuna.
Lote del Diluyente: Colocar el número y/o letras que figuran en el "lote" del envase.
Fecha de vencimiento: colocar la fecha de vencimiento que figura en el envase del diluyente.
El paciente recibió tratamiento para el evento. Indicar si el evento requirió tratamiento (farmacológico, quirúrgico, etc.) y de ser positivo, especificar el tratamiento.
En caso de sospecha de problemas de calidad: Completar la información solicitada.

D. **MEDICAMENTOS UTILIZADOS AL MOMENTO DE SER VACUNADO**
Registrar los medicamentos que está recibiendo el paciente al momento de ser vacunado. Considerar los productos farmacéuticos prescritos o automedicados. Excluir los medicamentos usados para tratar el evento.

E. **DATOS DEL NOTIFICADOR**
Establecimiento: Indicar el nombre completo del establecimiento (hospital, centro de salud, puesto de salud u otra institución) donde se detecta el ESAVI.
Nombres y apellidos, profesión, teléfono, correo electrónico (de contacto de la persona): Su objetivo es para solicitar información adicional y/o para canalizar una respuesta del caso notificado si es necesario.
Fecha de notificación: Indicar la fecha (Día/Mes/año) en que se completó el formato.
N° notificación: Este casillero será para uso exclusivo del Centro de Referencia Regional o Institucional de Farmacovigilancia.

Nota: El uso de los datos registrados en el presente formato se enmarca en las disposiciones legales sanitarias vigentes.

ANEXO 14
FICHA DE NOTIFICACION DE ERROR PROGRAMÁTICO RELACIONADO A LA VACUNACIÓN

Definición de Error Programático: Es toda desviación en los procedimientos estandarizados, recomendados en cualquier fase del ciclo de la vacuna desde su distribución por el fabricante, hasta su uso e incluido el desecho de residuos. No todos los errores programáticos llevan a un ESAVI, en ese caso, no serán objeto dentro de la vigilancia de ESAVI[3].

I NOTIFICACIÓN

Fecha de Notificación: _____/_____/_____
Día Mes Año

No. Caso:			Nombre del establecimiento que notifica: _____
DISA/DIRESA/GERESA/ _____			Teléfono: _____
Provincia: _____			
Distrito: _____			Persona que notifica: _____

1. PS ☐ 2. CS ☐ 3. Hosp.☐ 4. Instituto Naciuonal ☐
Minsa ☐ EsSalud ☐ FF. AA y PNP ☐ Sector Privado☐
Actividad al momento de vacunación del caso: Intramural ( ) Extramural ( )
Fue durante Campaña?: No ( ) Si ( )
Lugar de vacunación: Puesto fijo ( ) Puesto móvil ( ) Institucional ( ) Otro ( )
¿Cuál?:_____

DATOS DEL VACUNADOR
Nombres y Apellidos: _____ Teléfono y correo electrónico: _____
Profesión: _____ Cargo: _____
Centro Laboral_____
Experiencia Laboral (Años y Meses):_____

II IDENTIFICACIÓN DEL ERROR PROGRAMATICO

Marcar con "X" el tipo de error identificado

Tipo de error	No	Si
· Errores de prescripción o indicación. Ejm. Aplicación en edades no aprobadas		
· No evaluar contraindicación o precaución de la vacuna*		

[3] OPS. Manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización en la Región de las Américas. Washington, D.C, 2021.

· Error en la dosis a administrar ( ) Doble, ( ) triple, ( ) > 5 dosis _____ dosis		
· Error en el empleo el tipo de inmunobiológico utilizado		
· Errores de administración		
( ) Uso incorrecto de diluyentes,		
( ) Administración de otros productos distintos de las vacunas y sus diluyentes		
( ) Empleo de N° de aguja no indicada		
· Errores de manipulación - conservación de la temperatura, transporte y almacenamiento inadecuado		
· Errores de administración - error en la técnica de administración		
( ) Vía incorrecta		
( ) Lugar incorrecto (otro)_____		
· Errores en el procedimiento		
( ) Empleo de frascos multidosis en vez de monodosis		
( ) Técnica estéril incorrecta		
· Intervalo inadecuado entre vacunas		
· Exposición de la vacuna durante el embarazo		
· Uso de vacuna caducada		
· Vacuna con desviación de la calidad		

(*) Reacción de anafilaxia o hipersensibilidad al principio activo o excipiente incluido en la sección "composición de la vacuna" o una dosis anterior de esta vacuna; Personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida, incluidas con terapias inmunosupresoras por quimioterapia o dosis altas de corticosteroides sistémicos (p. ej., 20 mg/día o 2 mg/kg/día de prednisona durante 2 semanas o más) dentro de las cuatro semanas anteriores a la vacunación. Individuos con infección por VIH sintomática o infección por VIH asintomática cuando va acompañado de evidencia de función inmune comprometida

III BREVE RESUMEN DEL ERROR PROGRAMATICO

IV. INVESTIGACIÓN DEL ERROR PROGRAMATICO

1. ¿Cuáles fueron las causas que determinaron la generación del error programático?

2. ¿Cuáles son las medidas correctivas realizadas y por realizar para evitar recurrencias del error programático?

V. OPCIONES DE SEGUIMIENTO DEL ERROR PROGRAMATICO

Definitivamente no requiere seguimiento
( ) No ( )Si

Alto potencial de complicación con necesidad de seguimiento ( ) No ( )Si

¿Quién estará a cargo del seguimiento?

- **Establecimiento de salud/Microred/Red**_____

- **Equipo responsable del seguimiento**_____

- **Regularidad del seguimiento**

_____

- **Regularidad de remisión de informe de seguimiento al nivel regional**_____

Alta/ Cese de seguimiento _____

ANEXO 15
REQUISITOS PARA UN VACUNATORIO ADECUADO DE INMUNIZACIONES

1. Planta Física:

- El vacunatorio está ubicado en un lugar accesible al usuario, separado de los ambientes donde se traten enfermedades infectocontagiosas.
- El Vacunatorio cuenta con la señalización adecuada que diga "Vacunatorio".
- Contar con punto de agua y lavadero independiente, adicionalmente con servicios higiénicos.
- Contar con un ambiente de espera acorde al volumen de atención.

2. Equipamiento, Insumo y Mobiliario básico del servicio:

Cuenta con:

- Coche de curación
- Escritorio.
- Sillas.
- Estante.
- Equipo de cómputo.
- Camilla.
- Algodón, jabón líquido, clorhexidina 0.005%
- Vacunas y jeringas
- Termo porta vacunas, con paquetes fríos y data logger
- Dispensador de papel toalla.
- Cajas de bioseguridad (contenedores para descarte de jeringas y agujas).
- Tachos de basura.
- Riñonera mediana.
- Tambores de torunda de algodón de acuerdo a uso y demanda.
- Kit de emergencia para casos de anafilaxia (adrenalina-jeringa).
- Registro diario de vacunación unificado.
- Carné de vacunación para menor y mayor de 5 años.

3. Ambiente para cadena de frío

El ambiente para cadena de frío cuenta con sistema eléctrico y cableado de internet
Contar con:

- Refrigeradora para vacunas
- Congeladora para paquetes frío
- Termo porta vacunas
- Caja Transportadora
- Paquetes fríos de Termos con una cantidad para 2 recambios, según número de termos por modelo
- Mesa de preparación de paquetes fríos.
- Estantes acanalados de libre flujo de aire, inoxidable.
- Hoja de control de registro diario de temperatura de refrigerador y congelador
- Plan de Contingencia.
- Plan de mantenimiento preventivo.
- Cronograma de limpieza periódica de acuerdo a necesidad (equipos de cadena de frío).
- Reporte de registro de data Logger
- Termómetros de alcohol o digitales.

- Termohigrómetros.
- Data logger (Registrador de datos de Temperatura).
- Inventario de cadena de frio en inmunización, registrados en SIGA Patrimonio
- Sistema de alarma de temperatura y energía eléctrica.
- Aire acondicionado y grupo electrógeno, de acuerdo a la realidad local.
- Estabilizador de voltaje.
- Alumbrado de emergencia.
- Implementos de aseo, desinfección y contra incendio.
- Otros equipos de acuerdo a la necesidad y realidad local.

La cantidad de equipos de cadena de frío deberá estar acorde a la cantidad de vacunas que son requeridas según población asignada.

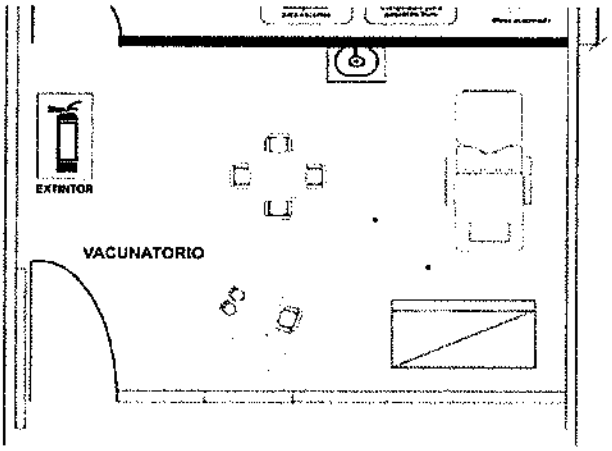
4. Personal

Los vacunatorios de las DIRIS/DIRESA/GERESA, cuentan con profesional de enfermería y técnico de enfermería capacitado en vacunación segura. La vacunación está a cargo del profesional de enfermería y en casos excepcionales por el técnico de enfermería capacitado. De acuerdo a la cantidad de vacunas administradas deberá considerarse a los profesionales de enfermería, para vacunación de niños y otro profesional de enfermería para vacunación de adultos entre otros grupos.

El profesional de enfermería responsable de administrar la vacuna en las diferentes etapas de vida debe garantizar la gestión y administración de las inmunizaciones de acuerdo a los niveles de responsabilidad, atendiendo a la demanda tanto intramural como extramural, para lograr las coberturas óptimas en su jurisdicción y de esta manera prevenir enfermedades inmunoprevenibles.

Se incluye al personal de mantenimiento, de almacén y de servicio que tiene relación directa o indirecta con la recepción, manipulación y transporte de las vacunas.

Gráfico 1. Croquis de distribución de un vacunatorio



Para la determinación del espacio físico del área de cadena de frío en inmunizaciones, se ha utilizado la metodología internacional de cálculo de áreas GUERCHET.

ANEXO 16
INDICADORES DE INMUNIZACIONES

Tipos de Indicadores:

Indicadores de Proceso, Resultado, Desempeño e Impacto

A) **Indicadores de Proceso**

➢ **Acceso:**

Es un indicador que nos permite identificar la proporción de niños que han sido captados por el servicio de vacunación a través de las primeras dosis de vacunas aplicadas dentro y fuera del establecimiento en relación a la población programada.

Se miden en vacunas que requieren más de una dosis para proteger al grupo objetivo según esquema de vacunación vigente.

Formula:

N° de primeras dosis aplicadas de vacuna (xxx 1) en <1 año X 100
Población total <1 año

Para el caso de IPV y Pentavalente o Hexavalente se toma en cuenta las 1eras dosis del mes de setiembre del año anterior hasta agosto del presente año a evaluar.

IPV1

$$\frac{\sum IPV1^{\frac{set(año\ anterior)}{agosto(año\ actual)}} \times 100}{Pob<1\ año}$$

PENTA/HEXAVALENTE1

$$\frac{\sum PENTA/HEXAVALENTE\ 1^{\frac{set(año\ anterior)}{agosto(año\ actual)}} \times 100}{Pob<1\ año}$$

Utilidad

- Se utiliza para analizar cuántos niños acceden efectivamente a los servicios de vacunación, que servirán para el seguimiento y completar los esquemas de vacunación.
- Verificar los denominadores de población. Cuando este indicador es superior al 100% existe la posibilidad que la población esté subestimada, o que el registro de grupo de edad no sea el adecuado, o que se están vacunando niños por fuera de los grupos de edad establecidos, o que se está vacunando población adscrita a otra jurisdicción.

Interpretación

- Cuando es del 100%, el acceso es adecuado y es factible la posibilidad de tener coberturas con terceras dosis superiores al 90%.

- Cuando es menor del 100%, disminuye la posibilidad de llegar a coberturas superiores al 90%, lo cual significa que hay dificultades para llegar a la población de los niños definidos en la programación.

➢ **Seguimiento:**

Este indicador mide la eficiencia del programa de inmunización al comparar las segundas dosis aplicadas (IPV, Pentavalente O Hexavalente) con las primeras, reflejando la retención de pacientes, la calidad del servicio de salud y el seguimiento del esquema, crucial para la protección completa del niño contra enfermedades prevenibles.

Formula:

N° de segundas dosis de vacuna en <1 año X 100
Población total <1 año

Ejemplo:

PENTA/HEXAVALENTE 2

$$\frac{\sum PENTA/HEXAVALENTE\ 2^{nov\ (año\ anterior)\ /oct\ (año\ actual)}\ x100}{Pob.\ <1\ año}$$

Utilidad:

- ❖ Nos permite medir el porcentaje de los niños que fueron vacunados con 2da dosis de acuerdo a los captados con 1eras dosis.
- ❖ Mide cuantos niños han regresado al establecimiento de salud para continuar el esquema, mide la calidad de la oferta del servicio.
- ❖ Para el caso de las vacunas IPV, PENTAVALENTE o HEXAVALENTE, se toman en cuenta las 2das dosis aplicadas desde el mes de noviembre del año anterior a octubre del presente año.

➢ **Cobertura**:

- Porcentaje de cobertura por cada tipo de vacuna.

  Mide el % de los niños(as) que completaron esquema de vacunación. Se calcula por cada tipo vacuna. El denominador lo constituye la población programada (meta).

Formula:

N° de Terceras dosis aplicadas de vacuna (xxx 3) en <1 año X 100
Población total <1 año

Ejemplos:

$$\frac{\sum PENTA/HEXAVALENTE3^{enero/dic\ (año\ actual)}\ x100}{Pob.\ < 1\ año}$$

El porcentaje de niños que completan el esquema de tres dosis de la vacuna PENTAVALENTE o HEXAVALENTE es un estándar para medir el éxito del programa.

¿Por qué es importante?

- Protección completa: Muchas vacunas requieren más de una dosis para lograr una protección duradera y eficaz.
- Inmunidad de grupo: Altas coberturas de dosis completas protegen a los más vulnerables que no pueden vacunarse, como neonatos o personas inmunocomprometidas, gracias a la inmunidad colectiva.
- Control y eliminación de enfermedades: Asegura que las metas de eliminación de enfermedades como el sarampión y la rubéola se mantengan en el tiempo.

➢ **Tasa de Deserción**

Es el número de niños(as) que no completaron el esquema de vacunación, que no se encuentran protegidos, nos permite identificar las brechas de los no vacunados o susceptibles identificando la situación de riesgo.

Resulta de la diferencia de las 1eras dosis (acceso) aplicadas en relación a las segundas o terceras dosis administradas según esquema y tipo de vacuna.

Deserción de Pentavalente:

$$\frac{\sum Penta/Hexavalente1^{\frac{set(año\ anterior)}{agost(año\ actual)}} - \sum Penta/Hexavalente3^{\frac{ener(año\ actual)}{dic(año\ actual)}} - \times 100}{Pob < 1\ año}$$

Deserción de SPR1:

$$\frac{\sum \boldsymbol{Penta/Hexavalente1^{\frac{marz(año\ anterior)}{feb(año\ actual)}} - \sum SPR1^{\frac{ener(año\ actual)}{dic(año\ actual)}} - \times 100}}{\sum \boldsymbol{Penta/Hexavalente\ 1^{\frac{marz(año\ anterior)}{feb(año\ actual)}}}}$$

Resumen de los indicadores de procesos de inmunizaciones

Seguimiento,

Años	Meses	PENTAVALENTE Acceso 1° dosis	Seguimiento 2° dosis	Cobertura 3° dosis
2024	Setiembre	31,329	0	0
	Octubre	32,974	0	0
	Noviembre	31,767	30,281	0
	Diciembre	27,894	29,033	0
2025	Enero	31,623	33,913	32,671
	Febrero	27,872	27,696	28,276
	Marzo	32,177	30,482	33,127
	Abril	31,223	28,187	28,392
	Mayo	32,479	30,023	28,546
	Junio	31,179	29,520	26,427
	Julio	31,094	29,926	27,814
	Agosto	30,989	30,984	29,342
	Setiembre	0	29,655	27,973
	Octubre	0	30,904	30,461
	Noviembre	0	0	23,219
	Diciembre	0	0	29,320
	Total	372,600	360,604	345,568
	Pob.<1a	384,427	384,427	384,427
	%	96.92	93.80	89.89
	Vacunado con 1°	372,600	0	0
	Desercion	0	27,032	7.25

Acceso **Cobertura**

Deserción

B) **Indicadores de Resultado: ENDES**

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD.

- Incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 15 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD.

- Incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus, 3 dosis de Neumococo y 1 dosis de SPR

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD.

- Incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus, 3 dosis de Neumococo, 2 dosis de SPR, 1 dosis de refuerzo de DPT y 1 dosis de refuerzo de Polio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

FICHA TÉCNICA

PORCENTAJE DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD

Nombre	Niño / Niña menor de 12 meses con vacunas para su edad
Objetivo	Determinar el porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses con vacunas para su edad.
Definición conceptual	Porcentaje de niño/niña menor de 12 meses que ha recibido las vacunas de acuerdo a su edad, según el Esquema Nacional de Inmunizaciones vigente o la que haga sus veces.
Población objetivo	Niñas y niños menores de 12 meses de edad.
Descripción operativa	Cociente del total de niñas y niños menores de 12 meses con vacunas para su edad y el total de niñas y niños menores de 12 meses de edad.
Unidad de medida	Porcentaje (%).
Fórmula	$PN<12VPE = \frac{TN<12VPE}{TN<12} * 100$
Variables	**TN<12VPE:** Niñas y niños menores de 12 meses con vacunas para su edad. **TN<12:** Total de niñas y niños menores de 12 meses de edad.
Construcción del indicador	Verificar en el carnet de vacunación el registro de las siguientes vacunas: 1 dosis de BCG 3 dosis de vacuna Anti polio - IPV 3 dosis de vacuna Pentavalente 2 dosis de vacuna Rotavirus 2 dosis de vacuna Antineumocócica
Fuente de los datos	Carné de vacunación, registro de vacunación, HIS MINSA, SIHCE
Periodicidad de los datos	Semestral y Anual
Nivel de inferencia	Nacional. Área de residencia (urbana y rural). Región natural (costa, sierra y selva). Departamental
Precisiones técnicas	Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación de los menores de 12 meses. Se pregunta por las vacunas de las enfermedades de mayor prevalencia en el país, como son la BCG (tuberculosis), Pentavalente (Difteria, Tos Ferina o Pertussis, Hepatitis B, Haemophilus Influenza y Tétano), APO/IPV (Poliomielitis), Antineumocócica (Neumonías), y Vacuna contra Rotavirus (EDAS por rotavirus)
Limitaciones	Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación y aquella proporcionada por la informante (madre) cuando no dispone de la tarjeta al momento de la entrevista. También se puede verificar los datos de la Historia Clínica del establecimiento de Salud. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso o cuando es un duplicado, y con el informe de la madre, cuando hay problemas de memoria o conocimiento
Entidad del Programa Presupuestal	Ministerio de Salud - MINSA

FICHA TÉCNICA
PORCENTAJE DE MENORES DE 15 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO SU EDAD

Nombre	Niño / Niña menor de 15 meses con vacunas para su edad
Objetivo	Determinar el porcentaje de niñas y niños menores de 15 meses con vacunas para su edad.
Definición conceptual	Porcentaje de niño/niña menor de 15 meses que ha recibido las vacunas de acuerdo a su edad, según el Esquema Nacional de Inmunizaciones vigente o la que haga sus veces.
Población objetivo	Niñas y niños menores de 15 meses de edad.
Descripción operativa	Cociente del total de niñas y niños menores de 15 meses con vacunas para su edad y el total de niñas y niños menores de 15 meses de edad.
Unidad de medida	Porcentaje (%).
Fórmula	PN<15VPE= $\frac{TN<15VPE}{TN<15}$ *100
Variables	TN<15VPE: Niñas y niños menores de 15 meses con vacunas para su edad. TN<15: Total de niñas y niños menores de 15 meses de edad.
Construcción del indicador	Verificar en el carné de vacunación el registro de las siguientes vacunas: 1 dosis de BCG 3 dosis de vacuna Anti polio IPV 3 dosis de vacuna Pentavalente 2 dosis de vacuna Rotavirus 3 dosis de Vacuna Antineumocócica 1 dosis de vacuna a SPR
Fuente de los datos	Carne de vacunación, registro de vacunación, HIS MINSA, HCE
Periodicidad de los datos	Semestral y Anual
Nivel de inferencia	Nacional. Área de residencia (urbana y rural). Región natural (costa, sierra y selva). Departamental
Precisiones técnicas	Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación de los menores de 15 meses. Se pregunta por las vacunas de las enfermedades de mayor prevalencia en el país, como son la BCG (tuberculosis), Pentavalente (Difteria, Tos Ferina o Pertussis, Hepatitis B, Haemophilus Influenza y Tétano), IPV (Poliomielitis), Antineumocócica (Neumonías), Vacuna contra Rotavirus (EDAS por rotavirus) y SPR (Sarampión, Rubeola y Papera).
Limitaciones	Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación y aquella proporcionada por la informante (madre) cuando no dispone de la tarjeta al momento de la entrevista. También se puede verificar los datos de la Historia Clínica del establecimiento de Salud. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso o cuando es un duplicado, y con el informe de la madre, cuando hay problemas de memoria o conocimiento.
Entidad del Programa Presupuestal	Ministerio de Salud - MINSA

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chuquos Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

FICHA TÉCNICA
PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO SU EDAD

Nombre:	Niño / Niña menor de 36 meses con vacunas para su edad
Objetivo	Determinar el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses con vacunas para su edad.
Definición conceptual	Porcentaje de niño/niña menor de 36 meses que ha recibido vacunas de acuerdo a su edad, según el Esquema Nacional de Vacunación Regular vigente o la que haga sus veces.
Población objetivo	Niñas y niños menores de 36 meses de edad.
Descripción operativa	Cociente del total de niñas y niños menores de 36 meses con vacunas para su edad y el total de niñas y niños menores de 36 meses de edad.
Unidad de medida	Porcentaje (%).
Fórmula	PN < 36VPE = $\frac{TN < 36VPE}{TN < 36}$ *100
Variables	TN<36 VPE: Niñas y niños menores de 36 meses con vacunas para su edad TN<36: Total de niñas y niños menores de 36 meses de edad.
Construcción del indicador	Verificar en el carnet de vacunación, el registro de las siguientes vacunas: 1 dosis de BCG 3 dosis de vacuna Anti polio (IPV) 3 dosis de vacuna Pentavalente 2 dosis de vacuna Rotavirus 3 dosis de Vacuna Antineumocócica 2 dosis de vacuna a SPR 1 dosis de vacuna de Refuerzo DPT 1 dosis de vacuna de Refuerzo de Anti polio (IPV)
Fuente de los datos	Carne de vacunación – registro de vacunación, HIS MINSA, SIHCE
Periodicidad de los datos	Semestral y Anual
Nivel de inferencia	Nacional. Área de residencia (urbana y rural). Región natural (costa, sierra y selva). Departamental
Precisiones técnicas	Este indicador se obtiene de la Historia y/o antecedente de Vacunación de los menores de 36 meses. Se pregunta por las usuales vacunas para las enfermedades de mayor prevalencia en el país, como son la tuberculosis, difteria, tos ferina, tétano, Hib, hepatitis B, poliomielitis, neumonía, diarrea por rotavirus y sarampión.
Limitaciones	Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación y aquella proporcionada por la informante (madre, padre o cuidadora) cuando no dispone de la tarjeta al momento de la entrevista. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud es rotado o cuando se trata de un duplicado y con el informe de la madre, cuando hay problemas de memoria y conocimiento
Entidad del Programa Presupuestal	Ministerio de Salud - MINSA

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

C) **Indicadores de Desempeño FED**

- **Porcentaje de Recién Nacido con Vacuna BCG y Hepatitis B dentro de las 24 horas después del nacimiento.**

  Mide el % de los niños(as) recién nacido que reciben una dosis de vacuna BCG y anti hepatitis B antes del alta (dentro de las 24 horas después del nacimiento). Para efectos del cálculo se considera a las niñas/niños registrados en el CNV en línea y HIS nacidos en el periodo de evaluación, excluyendo los niños nacidos con menos de 1500gr (registrado en el CNV en línea). El denominador lo constituye niñas/niños nacidos en hospital o instituto en el periodo de evaluación y se encuentran registrados en el CNV en línea, excluyendo los niños nacidos con menos de 1500gr.

  Fórmula:
  Total, de niñas/niños que recibieron 1 dosis de la vacuna BCG y anti hepatitis B antes del alta dentro de las 24 horas por 100 entre total de niños nacidos registrados en el CNV en línea, excluyendo los niños nacidos con menos de 1500gr.

- **Niñas y Niños menores de 12 meses de edad procedentes de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que reciben el paquete integrado de servicios FED**

  Mide el % de las niñas y niños menores de 12 meses de edad, del departamento, que reciben el paquete integrado de servicios, dentro de ello la vacunación:
  • Vacunas básicas según edad: antipolio, pentavalente, neumococo y rotavirus.

  Numerador
  N° de niñas y niños del denominador que reciben el paquete integrado de servicios según edad, y que han sido registrados en HIS y cuentan con DNI emitido.

  Denominador
  N° de niñas y niños menores de 12 meses de edad en el mes de medición, del departamento, registrados en el padrón nominal con DNI o CNV, con tipo de seguro SIS o sin Seguro.





- **Niños y niñas de 24 meses que reciben vacunas para su edad**

Mide el % de niños y niñas que al cumplir lis 24 meses de edad han recibido las vacunas de acuerdo a lo establecido en el Esquema Nacional de Inmunizaciones incluye:

1 dosis BCG, 3era dosis de IPV, 3era dosis de Pentavalente, 2da dosis de Rotavirus, 3ra dosis de antineumocócica, 1 dosis de AMA y la 2da de SPR

Fórmula del indicador	$\frac{\text{Niñas y niños del denominador de 24 meses que han recibido 1 dosis de BCG, 3era dosis de IPV, 3era dosis de Pentavalente, 2da dosis de vacuna Rotavirus, 3era dosis de vacuna antineumocócica, 1 dosis de vacuna antiamarílica y 2da dosis de SPR, registrado en HIS MINSA}}{\text{Número de niñas y niños de 24 meses en el mes de medición, registrados en el Padrón Nominal con DNI o CNV}} * 100$

- **Porcentaje niñas y niños de 9 años de edad vacunados contra el virus de papiloma humano (VPH).**

Mide el % Porcentaje niñas y niños de 9 años de edad vacunados contra el virus de papiloma humano (VPH).

Numerador
Número de niños y niñas de 9 años que han recibido una dosis de vacuna contra VPH, registrado en HIS MINSA

Denominador
Número de niñas/niños de 9 años de población RENIEC.

Fórmula del indicador

Número de niños y niñas de 9 años que han recibido una dosis de vacuna contra VPH, registrado en HIS MINSA
----------X 100
Número de niñas/niños de 9 años de población RENIEC

Nota: Considerando el ingreso progresivo de la vacuna Hexavalente por Pentavalente e IPV, se actualizarán todas las fichas técnicas de indicadores de vacunación.

ANEXO 17
CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

A. Esquema de vacunación de la población menor de 5 años

CRITERIOS DE PROGRAMACION EN MENOR DE 5 AÑOS

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración N° de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Recién Nacidos	100% de la población menor de 1 año, que se encuentren bajo la responsabilidad de: Centros maternos infantiles, hospitales y establecimientos de salud que atienden partos, de los Gobiernos Regionales y de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS). Fuente de información: Padrón nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores). Reporte HIS-MINSA de los 3 años anteriores. Información referencial: Sistema de Registro del Certificado de Nacidos Vivos en Línea y recién nacidos de los últimos 3 años.	BCG	1	Multidosis (frascos x 10 o 20 dosis)	20% en hospitales y centros maternos de mayor demanda. 40% en hospitales de poca demanda. 90% según la realidad y necesidad local en zonas muy dispersas o de poca demanda. (Pudiendo abrir un frasco x 10 dosis por cada niño).	0 a 24 horas de nacido (ideal) Hasta los 11 meses 29 días	PPOR - DIT
		HVB	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	0 a 12 horas de nacido (ideal) Máximo 24 horas de nacido. Excepcionalmente En caso de parto domiciliario se puede aplicar hasta los 7 días de nacido	
	Programar el 50% de los recién nacidos en el periodo estacional (abril -sept) Fuente de información: CNV del año anterior	Anticuerpo Monoclonal Nirsevimab	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Administrar inmunización al RN antes del alta hospitalaria, excepcionalmente hasta los 6 meses 29 días Se puede coadministrar con vacuna HvB o BCG	

EESS que no atienden parto deben coordinar con el C.M.I. más cercano para la vacunación del R.N en parto domiciliario

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Markely Centeno Acosta V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Población objetivo}	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración Nº de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Niños y Niñas menores de 1 año de edad	100% población menor de 1 año Fuente de información: Padrón nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores).	NEUMOCOCO	2	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	2, 4 meses	PPOR - DIT
		PENTAVALENTE O HEXAVALENTE CELULAR (*)	3	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	2, 4, 6 meses	
		ROTAVIRUS	2	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Hasta los 8 meses 0 días.	
	50% población menor de 1 año Fuente de información: Padrón nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores).	INFLUENZA PEDIATRICA	2	Multidosis (frascos por 20 dosis)	1.2 (20%)	(hasta los 11 meses, 29 días)	
	0.005% población menor de 1 año Reacción adversa al componente pertussis	HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (Hib)	2	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Menor de 5 años	
		DT PEDIATRICO	2	Multidosis (frascos x 10 dosis)	1.2 (20%)		
		HVB	2	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada		

(*) La vacuna hexavalente está supeditada su incorporación al agotamiento de stocks de vacuna pentavalente e IPV.

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración N° de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Niños y Niñas de 1 año de edad	100 % de Niñas y niños de 1 años Padrón Nominal Fuente de información: Padrón Nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores a la programación)	3ERA DOSIS NEUMOCOCO	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	12 meses	PPOR - DIT
		SPR	2	Multidosis (frascos por 5 o 10dosis)	1.2% (20%)	1era dosis: 12 meses y 2da dosis: 18 meses	
				Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada		
		VARICELA	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	1era dosis: 12 meses y	
		ANTIAMARILICA	1	Multidosis (frascos por 10 dosis)	1.5% (50%)	15 meses	
		HEPATITIS A	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	15 meses	
		1er REF PENTAVALENTE O HEXAVALENTE CELULAR (**)	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	18 meses	
		INFLUENZA PED.	1	Multidosis (frascos por 20 dosis)	1.2% (20%)	1 año	

** La vacuna hexavalente está supeditada su incorporación al agotamiento de stocks de vacuna pentavalente e IPV.

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración N° de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Niñas y niños de 2 años	100 % de Niños de 2 años Fuente de información: Padrón Nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores a la programación)	INFLUENZA PED	1	Multidosis (frascos por 20 dosis)	1.2% (20%)	2 años	**PPOR - DIT**

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Apaza V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

	100 % de Niños de 2 años	2da dosis VARICELA	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada		
Niñas y niños de 3 y 4 años	% 12 de Niñas y Niños de 3 y 4 años (Con y sin Comorbilidad) Fuente de información: Padrón Nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores a la programación).	INFLUENZA ADULTO	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	3 años y 4 años	
Niñas y niños de 2, 3 y 4 años	90 % de la brecha de vacunación de Niñas y Niños de 2, 3 y 4 años distribuido en 3 años: año 2026 el 50%, año 2027 el 20% y año 2028 el 20%. Fuente de información: Reporte de vacunados HIS histórico 2004-2025.	ANTIAMARILICA	1	Multidosis (frascos por 10 dosis)	1.5% (50%)	Al primer contacto con el servicio de salud. Es dosis ÚNICA para toda la vida Para cerrar brechas al 90% se elaborará plan progresivo de vacunación por 3 años.	
Niñas y niños de 4 años	100 % de Niñas y Niños de 4 años Fuente de información: Padrón Nominal Homologado y actualizado, cerrado (2 años anteriores a la programación).	2° REFUERZO DE APO	1	Multidosis (frascos x 20 dosis)	1.3% (30%)	4 años 11 meses y 29 días	
		2DO REFUERZO DE DPT	1	Multidosis (frascos por 10 dosis)	1.2% (20%)	4 años 11 meses 29 días	

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Markey Chirinos Adonis V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

B. Esquema de Vacunación en Población mayor de 5 Años´

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración Nº de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Niñas y Niños 9 a 18 años	**Niñas, Niños y adolescente de 9 a 18 años** 100% de niñas y niños de 9 años. 10% de población de 10 a 18 años que no recibieron ninguna dosis de vacunas **Fuente de información**: Población RENIEC Data de brechas de población de 10 a 18 años	VPH (Virus de Papiloma Humano	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	**dosis única,** con prioridad población de 9 años	**PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración Nº de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Gestantes	Programar el 90% del recién nacido, promedio de los últimos 3 años. Fuente de información: CNV de los últimos 3 años	Vacuna Tdap (acelular)	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Desde las 20 a las 36 semanas de gestación. Aplicación en cada embarazo	PP 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
	Programar el 50% gestantes esperadas se basa en data de nacimientos en el periodo estacional (abril -sept) del año anterior Fuente de información: CNV del año anterior	Vacuna VRS	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Desde las 32 a las 36 semanas de gestación. Aplicación en cada embarazo	
	Programar el 60% del del recién nacido, promedio de los últimos 3 años. Fuente de información: CNV de los últimos 3 años	INFLUENZA ADULTO	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	En cualquier trimestre	
	Programar el 35% del del recién nacido, promedio de los últimos 3 años. Fuente de información: CNV de los últimos 3 años	DIFTO TETANO ADULTO (DT)	2	Multidosis (frascos x 10 dosis	1.2 (20%)	Desde las 20 semanas de gestación 1ra dosis: al primer contacto con el servicio de salud 2da dosis: a los 2 meses de la 1era dosis.	
	Programar el 35% del del recién nacido, promedio de los últimos 3 años. Fuente de información: CNV de los últimos 3 años	HvB	3	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Desde las 20 semanas de gestación 1 era dosis: a partir del primer contacto 2da dosis: al mes de la primera 3ra dosis: al mes de la segunda.	

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chamos Apaza V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración N° de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Población de 5 a 59 años	**3 % de la Población INEI:** 5 a 19 años que no ha recibido vacunación o que tienen vacunación incompleta de vacuna pentavalente	HVB PEDIATRICA	3	Multidosis (frascos x 10 dosis)	1.2 (20%)	1era dosis al primer contacto con el servicio de salud. 2da al mes de la primera 3era al quinto mes de la primera dosis.	PROGRAMA PRESUPUESTAL VINCULADOS A LA CATEGORIA APNOP
				Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada		
	2% de la Población INEI: 20 a 59 años de población en Riesgo.	HVB ADULTO	3	Multidosis (frascos x 10 dosis) Monodosis	1.2 (20%) No tiene factor de dosis No utilizada	**1era dosis al primer** contacto con el servicio de salud. **2da** al mes de la primera dosis **3era** al sexto mes de la 1era dosis.	
	20% Población INEI de 5 a 59 años (Con y sin Comorbilidad)	influenza adulta	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Al primer contacto con el servicio de salud	
	90% de la brecha de la Población INEI de 5 a 59 años, distribuido en 3 años: año 2026 el 15%, año 2027 el 30% y año 2028 el 45%. Fuente de información: Reporte de vacunados HIS histórico.	ANTIAMARILICA	1	Multidosis (frascos x 10 dosis)	1.5 (50%)	Al primer contacto con el servicio de salud. Es dosis UNICA para toda la vida. Para cerrar brechas al 90% se elaborará plan progresivo de vacunación por 3 años.	
	1% Población de mayor de 7 años **Fuente. Población INEI**	DIFTO TETANO ADULTO (DT)	3	Multidosis (frascos x 10 dosis)	1.2 (20%)	**1ra dosis**: al primer contacto con el servicio de salud **2da dosis:** a los 2 meses de la 1era dosis. **3ra dosis:** a los 6 meses de la 1era. Dosis	
	50% de personal salud de áreas críticas de zonas con brote de tos ferina	Vacuna Tdap (acelular)	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Personal de salud de áreas criticas	
	1% Población de 7 a 59 años en zonas de brote de Tos ferina.					Población de 7 a 59 años en zonas de brote de tosferina	

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración N° de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad	Programa Presupuestal
Población de 60 años a más	60% Población de 60 años a más Fuente. Población INEI	INFLUENZA ADULTO (*)	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Al primer contacto con el servicio de salud (anual)	PROGRAMA PRESUPUESTAL VINCULADOS A LA CATEGORIA APNOP
	30% Población de 60 años a más: 1. Las regiones que no tiene brechas de vacunación acumulada desde el año 2019, programará el 50% de la corte de 59 años. 2. Las regiones que tiene brechas menores del 30% se programan el 100% de esa brecha. 3. Las regiones que brechas mayores del 30%, se programan solo el 30% de su brecha. Fuente. Población INEI	NEUMOCOCO	1			Al primer contacto con el servicio de salud (neurológicos, diabéticos, renales, demencia y Parkinson).	
Población en riesgo	2% Población de 5 a 59 años, (zonas de fronteras, Terrapuerto, aeropuertos y viajeros a zonas de riesgo, entre otros)	SARAMPIÓN PAPERA Y RUBEOLA /SARAMPION – RUBEOLA (SPR / SR)	1	Multidosis (frascos x 10 dosis) o	1.2 (20%)	Al primer contacto con el servicio de salud	
				Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada		
	1% Población comórbida de 5 a 59 años (Personal de Salud, VIH, TBC, Diabetes, Enfermedades Renales, Cardiopatías, Oncológicos, Respiratorias crónicas entre otros)	NEUMOCOCO	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Al primer contacto con el servicio (Personal de Salud y Comórbidos)	

C. Esquema de Vacunación Especial

Población objetivo	Criterio de Programación	Tipo de vacuna	Concentración N° de dosis	Presentación	Dosis No Utilizada	Consideraciones para valorar Oportunidad
Población de menor de 1 años	100 % de la Población de niños /niñas viviendo con VIH e inmunodeprimidos Fuente: Atenciones HIS/MINSA Estrategia de VIH/SIDA	Hexavalente acelular	3	Monodosis	No tiene factor de dosis no utilizada	Niños y niñas viviendo con VIH e inmunodeprimidos
Población de menor de 2 años (18 meses)	100 % de la Población de niños /niñas viviendo con VIH e inmunodeprimidos Fuente: Atenciones HIS/MINSA Estrategia de VIH/SIDA	Hexavalente acelular	1	Monodosis	No tiene factor de dosis no utilizada	Niños y niñas viviendo con VIH e inmunodeprimidos
Población de menor de 2 años (13 y 15 meses)	100 % de la Población de niños /niñas viviendo con VIH Fuente: Atenciones HIS/MINSA Estrategia de VIH/SIDA	Meningococo	2	Monodosis	No tiene factor de dosis no utilizada	Niños y niñas viviendo con VIH
Población de menor de 4 años	100 % de la Población de niños /niñas viviendo con VIH Fuente: Atenciones HIS/MINSA Estrategia de VIH/SIDA	DPT - IPV	1	Monodosis	No tiene factor de dosis no utilizada	Niños y niñas viviendo con VIH

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Wiesenfeld Chirinos-Asesora V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

De 9 a 26 años	0.13% de población de 9 a 26 años Fuente: Población RENIEC	VPH	3	Monodosis	No tiene factor de dosis no utilizada	1ra dosis al contacto 2da dosis a los 2 meses de la 1era dosis 3era dosis a los 6 meses de la 2da dosis
Población de 5 a 59 años	0.005% de Población: 5 a 59 años	DIFTO TETANO ADULTO (DT)	3	Multidosis (frascos x 10 dosis)	1.2 (20%)	1era dosis al primer contacto con el servicio de salud. 2da a los 2 meses de la primera. 3era a los 6 meses de la 1era dosis.
		HVB ADULTO	3	Multidosis (frascos x 10 dosis)	1.2 (20%)	1era dosis al primer contacto con el servicio de salud. 2da a los 7 días 3era a los 21 días Intervalo de 1 mes entre dosis y dosis. Dosis: 40 ug/2ml IM
				Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	
		HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (Hib)	1	Monodosis	No tiene factor de dosis No utilizada	Dosis Única

ANEXO 18
CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y EL NIÑO

PERÚ Ministerio de Salud — CARNÉ DE VACUNACIÓN DE LA NIÑA Y EL NIÑO		
Cod. De Afiliación:	H.C	N° Carpeta FAM:
Fecha de Nacimiento		
NOMBRES Y APELLIDOS		
De la Niña/Niño:		CUI/DNI:
De la Madre:		DNI:
Del Padre:		DNI:
Dirección:		
E-mail:	N° Teléfono fijo/Celular:	
Establecimiento:		
Programa de Apoyo Social:		

VACUNACIÓN (Anotar Fechas)		
Tuberculosis: (BCG) (Recién Nacido)		
Anti hepatitis B: (HVB) (Recién Nacido)		
Anticuerpo Monoclonal Rn hasta menores de 6 meses.....		
DOSIS de Antipolio Inyectable IPV		
1ra. (2 Meses)	**2da. (4 Meses)**	**3ra. (6 Meses)**
DOSIS de Pentavalente (DPT +Hib + HvB) o Hexavalente (DPT +Hib + HvB+IPV)		
1ra. (2 Meses)	**2da. (4 Meses)**	**3ra. (6 Meses)**
DOSIS de NEUMOCOCO		
1ra. (2 Meses)	**2da. (4 Meses)**	**3ra. (12 Meses)**
DOSIS de ROTAVIRUS		
1ra. (2 Meses)	**2da. (4 Meses)**	

INFLUENZA (<1 año)		**INFLUENZA 1 año**	**INFLUENZA 2 años**
1era. (6 Meses)	**2da. (7 Meses)**	**(1 Año)**	**(2 Años)**

SARAMPIÓN, RÚBEOLA y PAPERAS (SPR-1)	**VARICELA**	**ANTIHEPATITIS A (HVA)**	**ANTIAMARILICA**
(1 Año)	**(1 Año) 1ra dosis (2 Años) 2da dosis**	**(15 Meses)**	**(15 Meses)**

SARAMPIÓN, RÚBEOLA y PAPERAS (SPR-2)	**1er Refuerzo DPT**	**1er Refuerzo IPV**
(18 Meses)	**(18 Meses)**	**(18 Meses)**

2do. Refuerzo DPT	**2do. Refuerzo APO**
(4 Años)	**(4 Años)**

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Madeny Chirinos Apolo V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

ANEXO 19
CARNÉ DE VACUNACIÓN EN PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

CARNÉ DE VACUNACIÓN MAYORES DE 5 AÑOS

PERÚ | Ministerio de Salud

Nombres:	
Apellidos:	
DNI:	
Edad:	**Fecha Nacimiento:** / /
Distrito:	
Provincia:	
Dirección:	
Inst. Laboral:	

BIOLÓGICOS	DOSIS	FECHA	LOTE
Hepatitis B	1era Dosis	/ /	
	2da Dosis	/ /	
	3era Dosis	/ /	
Anti-Amarílica	Dosis Única	/ /	
SPR	1era Dosis	/ /	
	2da Dosis	/ /	
Influenza (Comor-bilidad/riesgo).	Dosis Única	/ /	
Tdap	Dosis Única	/ /	
dT adulto	1era Dosis	/ /	
	2da Dosis	/ /	
	3era Dosis	/ /	
VPH	Dosis Única	/ /	
Neumococo	Dosis Única	/ /	
VRS (gestantes 32 -36 sem)	Dosis Única	/ /	
OTRAS		/ /	
RECOMENDACIONES:			

1. Conservar y portar este carné es requisito para su vacunación.
2. Tres dosis es necesario para estar protegido contra la Hepatitis B, Tétanos y Difteria.
3. Cumplir con las fechas indicadas, vacúnate.
4. Si viajas a zonas endémicas de fiebre amarilla, vacúnate y porta este carné.

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Martínez Chirinos Esporta V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

ANEXO 20
PROGRAMACION DE INMUNIZACIONES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES y APNOP

A) PP 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

a) Cadena de frio en inmunizaciones

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						
NOMBRE DEL PROGRAMA	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**NOMBRE DEL SUBPRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CRITERIO DE PROGRAMACIÓN**	**FUENTE DE INFORMACIÓN**	**CRITERIO PARA DEFINIR EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, INCLUYE FUENTE.**
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000001 acciones Comunes	4427610 gestión operativa de la cadena de frio en inmunizaciones	060 informe	Programa solo MINSA, DIRESA, GERESA, DIRIS y Redes que son unidades ejecutoras. 01 Informe anual (consolidando todas intervenciones de cadena de frio en inmunizaciones)	Informe	Informe elaborado por los responsables regionales de cadena de frio en inmunización y remitido a la DMUNI del MINSA. El informe debe contener, información respecto a: * Actividades de mantenimientos preventivo especializado. * Actividades de mantenimiento recuperativo de los equipos inoperativos programados de acuerdo a sus necesidades del SIGA patrimonio actualizado (inventario de cadena de frio en inmunizaciones). * Actividades de evaluación de los equipos de cadena de frio en inmunizaciones, detallando las necesidades de mantenimiento preventivo o recuperativo, lugares de intervención, fecha y hallazgos identificados, conclusiones y recomendaciones. * Indicadores de cadena de frio en inmunizaciones Fuente: Base de datos de tramite documentario, registro de expedientes en las DIRESA/GERESA, DIRIS y MINSA según corresponda.

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Markemy Clemente Aponte
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

b) Niños y niñas con vacunas completas

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						
NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CRITERIO DE PROGRAMACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	CRITERIO PARA DEFINIR EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, INCLUYE FUENTE.
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325401 vacunación niño < 1 año	218 niño protegido	Programan EESS del 1, 2° y 3° nivel de atención, de acuerdo al siguiente detalle: Los EESS del 1° nivel de atención y del 2° nivel con población asignada, programan el 100% de población de niños < de 1ño, (11m y 29 días) registrados en el padrón nominal cerrado de hace 2 años anterior al año fiscal a programar, bajo su responsabilidad. Para establecimientos de 2do y 3er nivel de atención: Considerar la cantidad de niños que cumplieron su esquema de vacunación, según edad el año anterior Las metas del 2° y 3° nivel NO suma para la meta del subproducto, actividad y producto a nivel regional y nacional.	Para EE. SS con población asignada: Padron nominal cerrado con corte al 31 de diciembre de hace 2 años anterior a la programación. Para EE: SS de 2do y 3er nivel se usa HIS/MINSA: Reporte de niños vacunados del año anterior	Número de niños <1año protegidos con vacuna pentavalente registrado en HIS MINSA como Vacuna contra DPT-HvB-HiB (Pentavalente) Lab (3) código CIE / CPT: 90723. Se considera niño protegido cuando recibe sus 3 dosis de pentavalente Fuente: HIS/MINSA Reporte mensual Para la evaluación del resultado final se tendrá en cuenta como denominador el ajuste del padrón nominal al semestre y cierre del año fiscal (año actual que se realizó las actividades)
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325402 vacunación niño = 1 año	218 niño protegido	Programan EESS del 1, 2° y 3° nivel de atención, de acuerdo al siguiente detalle: Los EESS del 1° nivel de atención y del 2° nivel con población asignada, programan el 100% de población de niños de 1año, (1a, 11m y 29 días) registrados en el padrón nominal cerrado de hace 2 años anterior a la programación bajo su responsabilidad. Para establecimientos de 2do y 3er nivel de atención: Considerar la cantidad de niños que cumplieron su esquema de vacunación, según edad el año anterior Las metas del 2° y 3° nivel NO suman para la meta del subproducto, actividad y producto a nivel regional y nacional.	Para EE. SS con población asignada: Padron nominal cerrado con corte al 31 de diciembre de hace 2 años anterior a la programación. Para EE: SS de 2do y 3er nivel se usa HIS/MINSA: Reporte de niños vacunados del año anterior	Número de niños de 1 año vacunados con SPR1, registrado en HIS MINSA como Vacunación Anti sarampión, Paperas y Rubéola (SPR Lab (1) código CIE / CPT: 90707 Fuente: HIS/MINSA Reporte mensual Para la evaluación del resultado final se tendrá en cuenta como denominador el ajuste del padrón nominal al semestre y cierre del año fiscal (año actual que se realizó las actividades)
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325403 vacunación niño = 4 años	218 niño protegido	Programan EESS del 1, 2° y 3° nivel de atención, de acuerdo al siguiente detalle: Los EESS del 1° nivel de atención y del 2° nivel con población asignada, programan el 100% de población de niños de 4años (4a, 11m y 29 días) registrados en el padrón nominal cerrado de hace 2 años anterior a la programación bajo su responsabilidad Para vacuna AMA considerar 2% y para vacuna Influenza 12% Para establecimientos de 2do y 3er nivel de atención: Considerar la cantidad de niños que cumplieron su esquema de vacunación, según edad el año anterior Las metas del 2° y 3° nivel NO suman para la meta del subproducto, actividad y producto a nivel regional y nacional.	Para EE. SS con población asignada: Padron nominal cerrado con corte al 31 de diciembre de hace 2 años anterior a la programación. Para EE: SS de 2do y 3er nivel se usa HIS/MINSA: Reporte de niños vacunados del año anterior	Número de niños de 4 años vacunador con 2 dosis de DPT, registrado en HIS MINSA como Vacunación Anti Difteria, Pertusis y Tétanos (DPT) Lab (DA) código CIE / CPT: 90701 Fuente: HIS/MINSA Reporte mensual. Para la evaluación del resultado final se tendrá en cuenta como denominador el ajuste del padrón nominal al cierre del año fiscal (año actual que se realizó las actividades)

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Aponte V°B° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						
NOMBRE DEL PROGRAMA	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**NOMBRE DEL SUBPRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CRITERIO DE PROGRAMACIÓN**	**FUENTE DE INFORMACIÓN**	**CRITERIO PARA DEFINIR EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, INCLUYE FUENTE.**
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325405 vacunación niño = 2 años	218 niño protegido	Programan EESS del 1, 2 y 3er nivel de atención, de acuerdo al siguiente detalle: Los EESS del 1° nivel de atención y del 2° nivel con población asignada, programan el 100% de población de niños de 2años, 11m y 29 días) registrados en el padrón nominal cerrado de hace 2 años anterior a la programación bajo su responsabilidad Para establecimientos de 2do y 3er nivel de atención: Considerar la meta igual a lo ejecutado el año anterior Las metas del 2° y 3° nivel NO suman para la meta del subproducto, actividad y producto a nivel regional y nacional.	Para EE. SS con población asignada: Padron nominal cerrado con corte al 31 de diciembre de hace 2 años anterior a la programación. Para EE: SS de 2do y 3er nivel se usa HIS/MINSA: Reporte de niños vacunados del año anterior	Número de niños de 2 años vacunados con Influenza, registrado en HIS MINSA como Vacunación contra la influenza estacional código CIE / CPT: 90657 Fuente: HIS/MINSA Reporte mensual Para la evaluación del resultado final se tendrá en cuenta como denominador el ajuste del padrón nominal al semestre y cierre del año fiscal (año actual que se realizó las actividades)
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325406 vacunación niño = 3 años	218 niño protegido	Programan EESS del 1, 2° y 3° nivel de atención, de acuerdo al siguiente detalle: Los EESS del 1° nivel de atención y del 2° nivel con población asignada, programan el 12% de población de niños de 3años, 11m y 29 días, registrados en el padrón nominal cerrado de hace 2 años anterior a la programación, bajo su responsabilidad. Para establecimientos de 2do y 3er nivel de atención: Considerar la meta igual a lo ejecutado el año anterior Las metas del 2° y 3° nivel NO suman para la meta del subproducto, actividad y producto a nivel regional y nacional.	Para EE. SS con población asignada: Padron nominal cerrado con corte al 31 de diciembre de hace 2 años anterior a la programación. Para EE: SS de 2do y 3er nivel se usa HIS/MINSA: Reporte de niños vacunados del año anterior	Número de niños de 3 años vacunados con Influenza, registrado en HIS MINSA como Vacunación contra la influenza estacional código CIE / CPT: 90657 Fuente: HIS/MINSA Reporte mensual Para la evaluación del resultado final se tendrá en cuenta como denominador el ajuste del padrón nominal al semestre y cierre del año fiscal (año actual que se realizó las actividades)
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325408 atención de las reacciones adversas a las vacunas.	016 caso tratado	Programan: EESS. I-2, I-3, I-4, II Y III nivel de atención De acuerdo a la tendencia de casos de los últimos tres años reportados en el sistema de vigilancia	Reporte HIS/MINSA de atenciones y Reporte del sistema de vigilancia epidemiológica de los últimos 03 años.	Sumatoria de casos de ESAVIS atendidos.





PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						
NOMBRE DEL PROGRAMA	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**NOMBRE DEL SUBPRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CRITERIO DE PROGRAMACIÓN**	**FUENTE DE INFORMACIÓN**	**CRITERIO PARA DEFINIR EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, INCLUYE FUENTE.**
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325404 vacunación niño recién nacido	218 niño protegido	Programan EESS del 1°nivel de atención que atienden partos (I-3 y I-4) y EESS de 2° y3° nivel de atención que atienden partos. Los EESS I-3 y I-4 programan el 100% de la población menor de 1 año del padrón nominal cerrado hace 2 años a la programación. Para los niveles 2°° y 3° nivel de atención (hospitales que atienden partos) programan el promedio de recién nacidos vacunados en los últimos 3 años.	Padrón nominal Homologado y actualizado, cerrado al 31 de diciembre de hace 2 años anterior a la programación. Información referencial: Sistema de Registro del Certificado de Nacidos Vivos en Línea y recién nacidos de los últimos 3 años	Número de recién nacidos que reciben la vacuna BCG y HVB registrado en HIS MINSA como Vacunación Antituberculosa (BCG) (1) código CIE / CPT: 90585 más la Vacuna Anti hepatitis viral B (HvB) CIE / CPT: 90744 Fuente: HIS/MINSA Reporte mensual Para la evaluación del resultado final se tendrá en cuenta como denominador el ajuste del padrón nominal al semestre y cierre del año fiscal (año actual que se realizó las actividades)
1001 PPOR PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3033254 niños y niñas con vacuna completa	3325407 vacunación de niño de madre VIH	218 niño protegido	Programan EESS del 1, 2° y 3° nivel de atención. Programar el promedio de los últimos 03 años de niños nacidos de madre portadora VIH que completaron su esquema de vacunación, en el EESS.	HIS/MINSA: Reporte de niños vacunados el año anterior.	Número de niños menores de 1 año, nacidos de madre portadora VIH protegidos con neumococo, registrados en HIS MINSA, Vacunación antineumocócica Lab (3). infección por VIH sin SIDA código CIE / CPT: 90670 Fuente: HIS Reporte mensual

B. PP 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL						
NOMBRE DEL PROGRAMA	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**NOMBRE DEL SUBPRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CRITERIO DE PROGRAMACIÓN**	**FUENTE DE INFORMACIÓN**	**CRITERIO PARA DEFINIR EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA, INCLUYE FUENTE.**
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317211 VACUNACION A LA GESTANTE	747 GESTANTE PROTEGIDA	Programan los EESS del I, II y III nivel de atención. Considerar el 35% de gestantes esperadas en caso de Tdap, dT y HvB. La programación para la vacuna influenza es el 60% de gestantes esperadas.	Fuente: Reporte HIS MINSA	Total, de gestantes que reciben dosis de vacuna Tdap, según calendario vigente. Algoritmo para cálculo; Sumatoria de gestantes con registro en HIS Tdap: Código de registro HIS:90715

Nota: Las definiciones operacionales del sub producto Vacunación a la Gestante serán, actualizados una vez aprobada la presente norma, que oficializado al coordinador nacional del PP002

C. PP-024 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER						
NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CRITERIO DE PROGRAMACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	CRITERIO PARA DEFINIR EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE META FISICA
0024 programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer	3000683 niña protegida con VPH	5005137 proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH	218 niño tratado	100% de niñas de 9 años, 10% de población de 10 a 18 años sin ninguna dosis. 100% de 9 – 26 años de población con VIH	Población RENIEC, Fuente HIS/Minsa: Reporte mensual, trimestral, semestral y anual según corresponda, del año en curso.	Niñas de 9 a 18 años protegidas con 1 dosis de vacuna VPH 4 dosis a población con VIH Fuente HIS/Minsa Reporte mensual, trimestral, semestral y anual según corresponda, del año en curso.

D. PROGRAMA PRESUPUESTAL VINCULADOS A LA CATEGORIA APNOP

Producto	Actividad Presupuestal ID	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa
SIN PRODUCTO	5000393	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	Campaña de vacunación contra el Dengue, en las regiones
			Población mayor de 5 años que recibe la vacuna COVID 19 dosis única
			Población mayor de 5 años que recibe la vacuna Viruela Mono 2 dosis
	5000395	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	Población mayor de 5 años que recibe la Vacuna AMA 1 dosis
			Población mayor de 5 años que recibe la Vacuna HVB 3 dosis, según esquema primario
			Población mayor de 5 años que recibe la Vacuna Influenza adulto 1 dosis anual
			Población mayor de 5 años que recibe la Vacuna Neumococo 1 dosis única
			Población mayor de 5 años que recibe la Vacuna dT 3 dosis

MINISTERIO DE SALUD C. VILA

MINISTERIO DE SALUD Dirección de Inmunizaciones Lic. Liliana Marleny Chirinos Aparcana CCB° Dirección Ejecutiva Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

ANEXO 21
KIT DE INSUMOS CRÍTICOS Y GASTOS OPERATIVOS PARA ASEGURAR LAS INTERVENCIONES DE VACUNACION

BIENES Y SERVICIOS	RR.HH., SERVICIOS E INSUMOS
Recursos Humanos.	Licenciadas en Enfermería, técnicas de enfermería, técnicos digitación, ingeniero de sistema o estadístico. Servicio de Locación.
Financiamiento para acciones de seguimiento.	Movilidad Local (Urbana y Rural). Pasajes terrestres, fluviales y aéreos. Pago de viáticos al personal de brigadas de vacunación que se desplazan para realizar actividades de vacunación.
Mantenimiento preventivo y recuperativo de los equipos y complementos de cadena de frío.	Servicios de mantenimiento, compra de accesorios de repuestos para equipos de cadena de frío.
Transportes de vacunas a todos los establecimientos de salud, de las regiones del país.	Fletes, alquiler de movilidad terrestre, fluvial, pasajes.
Insumos y equipos médicos.	Algodón, Jabón líquido, papel toalla, guantes, Riñoneras, termos porta vacunas, cajas transportadoras, data logger, paquetes fríos, termómetros, equipo de cómputo, Kit de emergencia, etc.
Combustible.	Gasolina, petróleo, aceite lubricado.
Material de escritorio.	Carné de vacunación de niños y adultos.
ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS	**EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE INFORMACIÓN**
Equipos de cómputo.	Computadora, Laptop, Impresora.

MINISTERIO DE SALUD
C. VILA

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Liliana Marleny Chirinos Aponte
V°B°
Dirección Ejecutiva
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

X. BIBLIOGRAFIA

1. World Health Organization. Vacunas contra el rotavirus: documento de posición de la OMS. Wkly Epidemiol Rec. 2021.
2. Asociación Española de Pediatría. Hepatitis B. Comité Asesor de Vacunas. Madrid: AEP; 2024.
3. Asociación Española de Pediatría. Rotavirus. Comité Asesor de Vacunas. Madrid: AEP; 2024.
4. World Health Organization. Inmunización, vacunas y productos biológicos: documentos de posición. Ginebra: OMS; 2024.
5. Asociación Española de Pediatría. Bacillus Calmette-Guerin: vacunación en recién nacidos prematuros. Madrid: AEP; 2024.
6. World Health Organization. Vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH). Ginebra: OMS; 2022. Disponible en: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/diseases/human-papillomavirus-vaccines-(HPV).
7. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Embarazo y vacunas. Madrid: AEP; 2026.
8. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Recomendaciones de calendario de vacunación infantil. Madrid: AEP; 2026. Disponible en: https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-e-inmunizaciones-aep-2026.
9. Asociación Española de Pediatría. Inmunización en niños prematuros. Madrid: AEP; 2026.
10. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Inmunizaciones en niños infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Madrid: AEP; 2026.
11. World Health Organization. Vacunación con meningococo. Wkly Epidemiol Rec. 2024;99.
12. Becker S, Buffer A, McGrath L, Boggess K, Weber D. Effectiveness of prenatal tetanus, diphtheria, acellular pertussis vaccination in the prevention of infant pertussis in the U.S. Am J Prev Med. 2018;54(1):1-7.
13. Collaborative Group for Studies on Yellow Fever Vaccines. Duration of post-vaccination immunity against yellow fever in adults. Vaccine. 2014;32(39):4977-4984.
14. Organización Panamericana de la Salud. Evaluación multicéntrica de la efectividad de la vacuna de influenza estacional en América Latina y el Caribe, temporada 2018. Washington DC: OPS; 2018.
15. Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación. IX reunión ad hoc. Washington DC: OPS; 2025.
16. McMillan M, Clarke M, Parella A, Amirthalingam G, Helen S. Safety of tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination during pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129:560-572.
17. World Health Organization. Documentos de posición sobre las vacunas. Ginebra: OMS; 2024.
18. World Health Organization. Plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis, estrategia 2022-2026. Ginebra: OMS; 2022.
19. Centers for Disease Control and Prevention. Las vacunas recomendadas durante el embarazo ayudan a protegerlos a ambos. Atlanta: CDC; 2024. Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/downloads/Campaign-Toolkit-Factsheet_8.5x11_Color-es.pdf.
20. Siegrist C, Aspinall R. B-cell responses to vaccination at the extremes of age. Immunology. 2009; 9:185-194.
21. World Health Organization. Vacunas contra papiloma virus humano: documento de posición de la OMS. Ginebra: OMS; 2022.
22. World Health Organization. Vaccines against influenza: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(19):185-208.

23. World Health Organization. Vacunas contra la hepatitis B: documento de posición de la OMS. Wkly Epidemiol Rec. 2017; 92:369-392.
24. World Health Organization. Vacunas contra la poliomielitis: documento de posición de la OMS. Ginebra: OMS; 2022.
25. Vizzotti C, Neyro S, Katz N, Juárez M, Pérez M, Aquino A, Lisbster R. Maternal immunization in Argentina: a storyline from the perspective of a middle-income country. Vaccine. 2015; 33:6413-6419.
26. Vizzotti C, Juárez M, Bergel E, Romanin V, Califano G, Sangradini S, Rancaño C, Aquino A. Impact of a maternal immunization program against pertussis in a developing country. Vaccine. 2016; 34:6223-6228.
27. World Health Organization. Hepatitis B vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2017; 92:369-392.
28. World Health Organization. Vaccines and vaccination against yellow fever: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2013; 88:269-284.
29. World Health Organization. What is vaccine? Ginebra: OMS; 2024.
30. Garcia-Zamora S, Pulido L, Sosa Liprandi MI, Nacinovich F, Balsano FJ, Herrera Paz JJ, et al. Consensus document on the role of adult vaccination in the prevention of cardiovascular events. Medicina (B Aires). 2026;86(2):447-476.
31. World Health Organization. Influenza vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(19):185-208.
32. World Health Organization. Aplicación web denominada análisis de inventario y brechas de equipos (IGA). Ginebra: OMS; 2020.
33. Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones. Manual de inmunizaciones en línea de la Asociación Española de Pediatría. Madrid: AEP; 2026.
34. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Inmunología celular y molecular. 10a ed. Barcelona: Elsevier; 2022.
35. Organización Mundial de la Salud. Inmunización en pacientes inmunocomprometidos. Ginebra: OMS; 2023. Disponible en: [OMS – Inmunización de personas inmunocomprometidas](https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/immunization-in-immunocompromised-persons?utm_source=chatgpt.com)
36. Organización Nacional de Trasplantes. Manual de coordinación de trasplantes. 6a ed. Madrid: Ministerio de Sanidad de España; 2022.
37. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2009;9(Suppl 3):S1-S155.
38. Forés R, Cabrera R. Trasplante hematopoyético. En: Burgaleta C, editor. Libro blanco de la hematología y hemoterapia en España. Madrid: EDIMSA; 2012. p. 61-69.